

CONVULSÃO FEBRIL — SIMPLES x COMPLEXA

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM



DEFINIÇÃO

O QUE É

- Crise convulsiva associada a FEBRE (> 38 C), entre 6 meses e 5 anos, sem infecção intracraniana ou causa definida
- NÃO é epilepsia; história familiar positiva em ~25%
- Excluir: crises afebris prévias (afastam o diagnóstico), infecção do SNC, distúrbio metabólico, trauma
- Gatilho frequente: vacinação recente; foco febril comum (IVAS, OMA, GECA, roséola/HHV-6)

SIMPLES x COMPLEXA

Característica	Simples (75%)	Complexa (25%)
Duração	< 15 minutos	> 15 minutos
Tipo	Generalizada (tônico-clônica)	Focal (início/fim localizado)
Recorrência em 24h	Única	Múltipla (recorre em 24h)
Pós-ictal	Recuperação rápida e completa	Déficit transitório (paralisia de Todd)
Prognóstico	Benigno	Risco aumentado de epilepsia futura

RED FLAGS — INVESTIGAR / PENSAR EM SNC

SINAIS DE ALARME

- Crise prolongada (> 15 min — estado de mal) ou FOCAL; recorrência em < 24h
- Déficit neurológico pós-ictal persistente (Todd > 15 min); rebaixamento persistente
- Sinais de HIC (vômitos, cefaleia, fontanela tensa) e sinais MENÍNGEOS (rigidez de nuca, PETÉQUIAS)
- Idade < 6 meses ou > 5 anos (questionar o diagnóstico de CF)
- Trauma recente; sinais de infecção do SNC

TRATAMENTO DA CRISE AGUDA

Rx SE CRISE > 5 MIN OU ATIVA NA CHEGADA

ABCDE: via aérea (aspirar, decúbito lateral), O2 se SatO2 < 92%, acesso venoso se crise persistente

BENZODIAZEPÍNICO (1a linha), repetir após 5 min se não cessar:

Midazolam IM 0,2 mg/kg (máx 6 mg) — opção sem acesso venoso

Midazolam EV: 6m-5a 0,05-0,1 mg/kg (máx 6 mg); 6-12a 0,025-0,05 mg/kg (máx 10 mg)

Controle térmico: banho morno + antitérmico (Dipirona 15 mg/kg/dose EV ou 0,6 gota/kg; Paracetamol 10-15 mg/kg/dose)

Crise refratária aos benzodiazepínicos -> manejar como estado de mal epilético

QUANDO PEDIR EXAMES

INVESTIGAÇÃO SELETIVA

- CF SIMPLES com foco definido: exames de rotina (hemograma, eletrólitos, glicemia, imagem) NÃO são necessários
- PUNÇÃO LOMBAR: < 1 ano -> considerar (sinais meníngeos frustros); > 1 ano -> apenas se suspeita de infecção do SNC
- Neuroimagem (TC/RM): apenas em crise COMPLEXA, sinais focais, HIC ou suspeita de trauma
- Glicemia capilar em toda crise (excluir hipoglicemia)
- Identificar e tratar o foco febril

PROFILAXIA E INTERNAÇÃO

CONDUTA

- CF simples: NÃO indicar profilaxia de rotina (quadro benigno)
- Profilaxia intermitente (na vigência da febre): benzodiazepínico (diazepam 0,3-0,5 mg/kg 8/8h por 24-48h) — casos selecionados; vigiar sonolência/depressão respiratória
- Profilaxia contínua (especialista): valproato ou fenobarbital em casos específicos (estado de mal, crises recorrentes)
- INTERNAR: CF complexa, estado de mal, suspeita de infecção do SNC, toxemia/instabilidade, < 1 ano com incerteza diagnóstica
- ALTA (CF simples): recuperado (Glasgow 15), foco benigno identificado, sem sinais meníngeos, observação 2-4h sem nova crise, pais orientados

ORIENTAÇÕES AOS PAIS (ALTA)

EM CASA

- ☐ Tranquilizar sobre a BENIGNIDADE da CF simples (não causa lesão cerebral)
- ☐ Em nova crise: proteger, lateralizar a criança e NÃO colocar nada na boca; cronometrar a duração
- ☐ Controle da febre com antitérmico (não previne a recorrência, mas dá conforto)
- ☐ Retornar IMEDIATAMENTE se: nova crise, crise > 5 min, vômitos, manchas na pele (petéquias), sonolência excessiva
- ☐ Seguimento ambulatorial com pediatra

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Criança ____ anos com crise ____ (simples/complexa); febre há ____; duração ____ min; recorrência: ____.
- Neuro: Glasgow ____, sinais meníngeos ____, déficit focal (Todd?) ____; foco: ____.
- Conduta: ABCDE, benzodiazepínico ____, controle térmico; PL/TC: ____.
- Solicito internação/UTI se complexa/estado de mal/suspeita de meningite.

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Criança de 2 anos, crise tônico-clônica generalizada de 3 min durante febre por OMA, recuperada e sem sinais meníngeos. Classificação e conduta?

- A) Convulsão febril complexa — internar e fazer punção lombar
- B) Convulsão febril simples — tratar o foco, orientar os pais e dar alta após observação
- C) Epilepsia — iniciar valproato
- D) Meningite — antibiótico endovenoso
- E) Estado de mal — fenitoína

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual achado caracteriza convulsão febril COMPLEXA?

- A) Crise generalizada de 5 minutos, única
- B) Crise focal, ou > 15 minutos, ou recorrente em 24h
- C) Recuperação rápida e completa
- D) Idade de 2 anos
- E) Febre por IVAS

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual a primeira linha medicamentosa para a crise convulsiva febril ativa (> 5 min)?

- A) Fenobarbital oral
- B) Benzodiazepínico (ex.: midazolam IM/EV)
- C) Ácido valproico
- D) Paracetamol
- E) Fenitoína oral

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Em qual situação a punção lombar deve ser fortemente considerada na convulsão febril?

- A) Toda criança com convulsão febril simples
- B) Lactente < 1 ano (sinais meníngeos podem ser frustrados) ou suspeita de infecção do SNC
- C) Apenas se febre > 40 °C
- D) Nunca
- E) Somente em crianças > 5 anos

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Sobre a profilaxia na convulsão febril simples, é correto:

- A) Toda criança deve usar anticonvulsivante contínuo
- B) Não se indica profilaxia de rotina (quadro benigno); intermitente/contínua só em casos selecionados
- C) Profilaxia com fenitoína para todos
- D) Antitérmico contínuo previne a recorrência
- E) Internação para todos

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Crise generalizada < 15 min, única, com recuperação completa e foco febril benigno = convulsão febril simples. Conduta: tratar o foco, orientar os pais e dar alta após período de observação. Não exige PL nem exames de rotina.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A CF complexa tem pelo menos um de: crise focal, duração > 15 min, ou recorrência em 24h (e/ou déficit pós-ictal). Associa-se a maior risco de epilepsia futura.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A primeira linha da crise ativa é o benzodiazepínico (midazolam IM se sem acesso, ou EV), repetível após 5 min, junto ao controle térmico. Valproato/fenobarbital são para profilaxia contínua selecionada.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A PL deve ser considerada em lactentes < 1 ano (sinais meníngeos podem ser sutis) e sempre que houver suspeita de infecção do SNC. Em > 1 ano, só se houver suspeita clínica.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Na CF simples não se indica profilaxia de rotina, dada a benignidade. Profilaxia intermitente (benzodiazepínico na febre) ou contínua (valproato/fenobarbital) ficam para casos selecionados, com especialista.

SM24
Suporte ao Plantão Médico